

8- Le Coeur_Mise en Place du Mouvement Developmental

Sur un plan fluide, au départ, cette phase de congestion liée à la réorganisation de mon mésoderme par rapport à mon tube neural, qui fait qu'il y a une trajectoire qui va faire qu'il va y avoir une concentration vers le haut, va amener en haut, ici, des cellules angiogéniques primitives qui vont se concentrer. Tout ce processus amène un tube cardiaque qui, au départ, est un tube aortique primitif à gauche et à droite, mais qui vient se concentrer par la vitesse de croissance différentielle entre le tissu d'intérieur et le tissu d'extérieur, qui fait qu'il va y avoir cette flexion de l'embryon. Ce mouvement de flexion va amener les aortes vers le centre. Cette rencontre des deux aortes vers le centre va être aussi la cause pour former le cœur. C'est toute une combinaison. Je l'ai depuis mon cœcyx sur la zone précardiaque qui est ici, et qui, au départ, était là, avant que j'aie le mouvement de développement du cerveau. Au départ, deux aortes, par le tube neural qui se développe, qui a le moteur, la cavité amniotique énorme autour, et la vitesse de croissance différentielle de mes aortes, viennent se rapprocher vers ma ligne médiane, devant la notochorde. Ces deux tubes, ici, dans le temps, viennent se rencontrer vers la ligne médiane, comme ceci. Et ici, normalement, il y a une sorte de tissu d'intérieur spécifique, ici, nutritif, et bien, si je n'ai plus cette rencontre, ce tissu d'intérieur ici, j'ai un champ de corrosion qui va apparaître. Il va y avoir une connexion petit à petit, et ce premier point de rencontre, ici, va donner une structuration du début du cœur. Donc, c'est une rencontre sur la ligne médiane de ces deux niveaux. Mais n'oubliez pas qu'il faut voir ça depuis l'extérieur vers l'intérieur. Si on reprend depuis le début, je vois ici une couche de cellules qu'on va appeler la couche qui était au-dessus du cœur, parce que si, maintenant, je fais une image avant, on va voir ça tendu comme ça. Ce tissu qui est ici, c'est déjà un tissu qu'on appelle les cellules mésenchymateuses qui feront le péricarde et le septum transversum. Donc, à la fois, la

relation avec mon cœur et mon diaphragme. Le cerveau qui se développe va s'enrouler autour du cœur. On voit que la cavité amniotique vient pousser tout autour. Et au centre, ça va ramener mes vaisseaux qui viennent se rejoindre devant ma notochorde. La vitesse de croissance entre ce tube cardiaque mésodermique pur, qui est à la fois le moteur pour la croissance, mais en même temps, l'organisateur de ma croissance, devient un champ de restriction par rapport à la cavité amniotique qui pousse comme ceci, mais qui est informée par mon tube neural, qui, lui, reçoit la plus grande information trophique, grandit le plus vite et amène l'embryon à faire un mouvement de flexion. C'est le système qui vient s'enrouler autour du cœur. Mais donc le cœur, en fait, il est toujours à sa place. C'est le système qui vient s'enrouler autour. Et dans ce processus, il y a la seule chose, c'est que j'ai une vitesse de croissance ralentie et un rapprochement des fluides de l'extérieur, de la périphérie, vers le centre. C'est pour ça qu'on voit ici que le mouvement de céphalisation va entraîner l'espace de cardialisation, qui va entraîner petit à petit la diaphragmatisation. Et on va voir plus tard, va entraîner ce qu'on appelle l'hépatisation. Et comme on avance, on va voir que cette hépatisation va entraîner en fait la surrénalisation qui va entraîner la gonadisation. Et donc j'ai tout un mouvement ici de développement très intéressant qui est lié au développement de ma cavité amniotique qui va complètement emballer ce que j'appelle la zone B, tu vois. La céphalisation entraîne la cardialisation qui va entraîner la diaphragmatisation, qui va entraîner toute la partie postérieure de la cavité péritonéale, tout le mouvement de la ligne médiane par exemple chez la femme qui va former l'utérus et les trompes, et chez l'homme, un mouvement qui ne va pas jusqu'au bout mais qui va former sa prostate sur le plan médian. Puis ça va revenir dans la partie ici et je vais avoir tout le système du périnée qui va se développer ici et un retour vers cette bascule ici qui est en fait un rééquilibrage de mon

foie, qui en fait à ce moment-là va faire sa bascule et ce mouvement latéral. Le foie devient une grande source d'organisation pour l'ensemble de mon développement et la fermeture de ma ligne médiane antérieure. Ce qui est important de retenir ici, c'est que j'ai un rapprochement vers ma ligne médiane et que le cœur d'abord se développe vers cette ligne médiane antérieure. Mais au même moment, j'ai un processus important de céphalisation. En jaune c'est la cavité amniotique, en bleu l'ectoderme du cerveau en développement, puis j'ai ici une autre zone quelcœur et là la zone diaphragmatique qui vient s'intégrer ici avec l'intégration petit à petit de ma vésicule vitéline qui va se rencontrer petit à petit sur ce qu'on appelle le pédicule embryonnaire pour former le cordon ombilical. Donc tout ça c'est un mouvement développemental avec une zone très intéressante. C'est ma cavité amniotique qui va organiser tout ça. Finalement c'est un équilibre entre le système aortique, donc l'axe vasculaire, et la cavité amniotique. Tu vois le cœur qui est ici, là. Finalement c'est le cerveau qui est venu autour. Donc j'ai un mouvement comme ça. Juste intégration. Et puis je vais avoir un mouvement qui va faire ça pour former le diaphragme, toute la peritoine pariétale postérieure et puis ça revient autour. Si je reprends mes mains dans cette position, ceci devient un point d'appui, ça fait ceci. Je fais à l'envers. Un point d'appui qu'on va étudier, ce sera par rapport au cœur, par rapport au cerveau. Par rapport à l'origine, je me mets coccyx, cerveau et cœur ici. Donc là je suis dans son ébauche embryonnaire, si tu veux. Ça dépend si tu prends un autocorps, tu es coccyx ou pas. Là j'ai juste pris la ligne primitive. Ça peut m'amener déjà à quelque chose d'assez important parce que la ligne peut être déviée à la naissance, elle peut être déviée à la conception, elle peut dévier dans le pré-conceptuel. Ça vaut à voir où tu peux reconnecter. Pour aller donner une information, qu'elle soit dans un mot, dans un geste ou dans une présence ou dans quelque chose que le corps doit

m'exprimer. Ensuite, le cerveau et le cœur, ils se connaissent bien. Le cœur était là. Il est là. Mais lui, il n'a pas bougé. Petit à petit, cette notion, c'est ma cavité amniotique qui se forme dans ce mouvement-là. C'est un travail qu'on va faire sur la zone B. On va intégrer aussi les forces latérales. Donc la force de délimitation transversale thoraco-abdominale dans l'intégration du système circulatoire, de la périphérie vers le centre. Comme ça, on aura tout le mouvement. La zone B, pour moi, dans cette intégration ici, ça va être la cavité amniotique. Si tu as un bébé qui est ici, tu flottes dans ta cavité amniotique. Cette enveloppe va disparaître au niveau membranaire. Mais l'aspect énergétique, elle est là. Cette espèce de boule autour de toi que tu as besoin. Si tu le vois déjà dans l'intégration de ceci, cette cavité amniotique, elle forme ton tube neural. Elle est intégrée dans ton tube neural. Ça veut dire que quand tu as un whiplash, quand tu as un problème d'une dysfonction au niveau crânio, sacré, ou bien sur le cor links ou quoi que ce soit, si tu n'arrives pas à remettre, va avant. Traite la cavité amniotique. Redonne les espaces entre sacrum, cœur. Tu refais tout le mouvement et tu vois où ça bloque. Et puis tu peux retravailler. Et tu laisses le système travailler dans cette reconnaissance des neutres. Ou alors tu peux le faire toi-même. Et puis tu travailles sur les processus latéraux. Mais ça, on les reverra. Une coupe transversale. Au-dessus, j'ai ma cavité amniotique. Une gouttière neurale. Donc le liquide qui est ici, qui est du liquide amniotique primitif. Jusqu'à ce que ça va former un tube neural. Il va être intégré dans ce tube. Il y a la fermeture de mon neuroport antérieur et mon neuroport postérieur, c'est-à-dire le 28ème jour. Ce tube est fermé. Tu dois plutôt te mettre vraiment sur la zone B. Parce que c'est elle qui intègre ton LCR. C'est pas l'inverse. Il apparaît quand tu rentres dans la muqueuse. Cet embryon, j'ai le bouton embryonnaire. Et au moment où il rentre dans la muqueuse, ici, j'ai un exudat qui apparaît ici. Et ça, c'est ma cavité amniotique qui

va créer ton tube neural, ta plaque neurale et ton tube digestif. Je ne peux pas séparer, sur un plan fonctionnel, le reste de cette cavité. Elle est toujours intégrée. Tu vas avoir ce cellulome externe qui, par le mouvement de développement de l'embryon, va intégrer le cellulome externe en un cellulome interne pour une grande partie. Et le reste va partir sous forme d'exudat à l'extérieur. Il est repoussé par la cavité amniotique. Dans la croissance, à un moment donné, il ne se développe plus. C'est-à-dire que tu as eu le canal neurothérique qui est une information entre la vésicule vitéline et la cavité amniotique. Rien à voir avec le cellulome externe. Le cellulome externe sera intégré en un cellulome interne pour former la cavité péritoneale. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de croissance de cette cavité. Donc on a l'impression qu'elle va être repoussée. Mais non ! Il y avait un litre, mais l'autre grandit tellement et est dans la croissance que finalement, c'est un exudat. Sauf qu'elle aura intégré un cellulome interne.